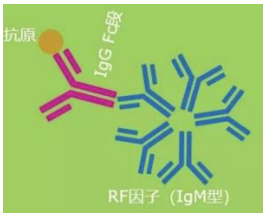
三、自身抗体



1.类风湿因子 RF（IgM，此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段）：80%阳性（出道早）

2.抗瓜氨酸化蛋白抗体 ACPA

①**抗环瓜氨酸肽抗体 CCP：敏感性和特异性都高，利于早期诊断、价值优于 RF**

②抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体

③抗聚角蛋白微丝蛋白抗体

④抗核周因子抗体

⑤抗角蛋白抗体（和瓜瓜 ttsx 一起（聚）周游每个（敏感性和特异性）角落）

抗体小结：

治疗首选GC

在RBC上打补丁 在PLT上打补丁 无天然抗体

IgG：多数疾病，如温抗体型自免溶、ITP、Rh 血型系统、骨髓瘤、SLE

IgM：RF、冷抗体型自免溶、ABO 血型系统天然抗体、检测支原体等提示现症感染（ABO 在冷风天检测支原体）

IgE：支气管哮喘

血管内溶血

原发，1~3天 继发，双下肢对称出血点，周为单位的前驱感染

IgA：IgA 肾病、过敏性紫癜肾炎、分泌性蛋白尿

IgD：骨髓瘤肾功能损害最常见（D 长得像肾）

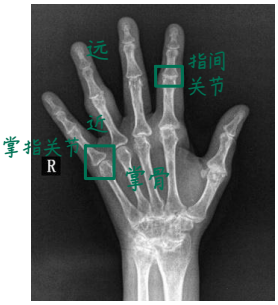


四、影像学

看软组织

①**MRI：早期诊断** 发现渗出肿胀(对液体敏感)

②**手指及腕关节 X 线分期**（种树摘虫子）



I：关节周围软组织**肿胀**、关节端**骨质疏松**

II：关节间隙变**窄**

III：关节面出现**虫噬样骨质破坏**

IV：关节**半脱位**、纤维性或骨性**强直**

五、治疗

免疫问题没有SLE强烈

同服 NSAIDs 或糖皮质激素+**改善病情抗风湿药 DMARDs** 晚期关节畸形不可逆,故需尽早使用

①NSAIDs 首选选择性 **COX-2** 抑制剂（**塞来昔布、美洛昔康**等）以减少胃肠道不良反应

②糖皮质激素可**短**疗程作为桥梁治疗：在传统 DMARDs 起效前快速控制活动性疾病，待传统 DMARDs 起效后减停。一般**小**剂量，但有关节外表现特别是继发血管炎应予以中到大量 GC VS 狼疮危象:大剂量糖皮质激素冲击治疗

③**DMARDs 能控制病情进展**：传统 DMARDs **首选甲氨蝶呤**（起效慢），效果不佳可联合靶向 DMARDs 如乌帕替尼（JAK 抑制剂）、或生物 DMARDs 如益赛普（TNF 拮抗剂）、IL-6 拮抗剂

注意：首选甲氨蝶呤的有类风湿、中枢白血病（假嘞老白）

④关节镜下滑膜切除术，人工关节置换术

六、诊断标准

（一）《内科学》10 版教材 P817

VS痛风:起病急,夜间痛,第1跖趾关节受累(大脚趾痛)

①关节受累（疼痛肿胀）：小关节包括腕关节、掌指关节、近端指间关节、第 2-5 跖趾关节，**不包括远端指间关节**、第一腕掌关节、第一跖趾关节。大关节包括肩、肘、髋、膝、踝关节

骨关节炎特点

②血清学指标：**CCP**、RF

③滑膜炎持续时间：6 周为界

④急性时相反应物：C 反应蛋白 CRP、血沉 ESR

